

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/11081156>

[Dimensions of subjective well-being in elderly persons]

Article in *Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie* · October 2002

Source: PubMed

CITATIONS

18

READS

155

4 authors, including:



Alfons Marcoen

KU Leuven

78 PUBLICATIONS 4,726 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Wim Beyers

Ghent University

127 PUBLICATIONS 11,798 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Dimensies van subjectief welbevinden bij ouderen

Alfons Marcoen^a, Karolien Van Cotthem^b, Katrien Billiet^b en Wim Beyers^c

Samenvatting

Subjectief welbevinden is een belangrijk thema in de psychogerontologische theorie en praktijk. Tegen de achtergrond van het onderscheid tussen de hedonistische en de eudaimonische concepten van welbevinden wordt een zes-dimensioneel relationeel model geschetst van subjectief welbevinden. Een nieuw instrument voor de meting van psychologisch, lichamelijk, sociaal, materieel, cultureel en existentieel welbevinden, respectievelijk, werd in 2000 getest in een groep van 366 ouderen (61% vrouwen) van 60 jaar en ouder. Na itemanalyse en exploratieve factoranalyse van de afzonderlijke schalen bleven 56 van de 72 items over, verdeeld over zes meer homogene schalen met aanvaardbare alfa-coëfficiënten gelegen tussen 0,89 en 0,61. Voor alle schalen, maar vooral voor Lichamelijk, Psychologisch, Existentieel en Cultureel Welbevinden, werden verbanden gevonden met een aantal demografische en persoonsvariabelen, zoals aantal kinderen, al of niet dochters hebben, zelfstandig wonen, veel vrienden hebben, enz.

Summary: *Dimensions of subjective well-being in elderly persons.* Subjective well-being is an important and relevant theme in psychogerontological theory and practice. Against the background of the distinction between hedonistic and eudaimonic conceptions of well-being a six-dimensional relational model of subjective well-being is described. A new instrument for the measurement of psychological, physical, social, material, cultural and existential well-being was tested in a sample of 366 elderly persons (61% women) aged 60 years and older. After item analysis and exploratory factor analysis of the different scales, 56 items of the original 72 were retained for six more homogeneous scales with acceptable Cronbach's alphas between .89 and .61. Relations were found between the scores on different scales - especially on the scales for Physical, Psychological, Existential and Cultural Well-being - and some demographic and person-related variables such as, number of children, presence or absence of daughters, living independently, availability of friends, etc.

Trefwoorden: subjectief welbevinden, dimensies welbevinden, ouderen
Tijdschr Gerontol Geriatr 2002;33:156-65

^a Hoogleraar Ontwikkelingspsychologie, Centrum voor Ontwikkelingspsychologie, Katholieke Universiteit Leuven

^b Klinisch psycholoog

^c Postdoc Ontwikkelingspsychologie, Katholieke Universiteit Leuven

Correspondentie:

Alfons Marcoen, Centrum voor Ontwikkelingspsychologie, Tienestraat 102, 3000 Leuven

Inleiding

Probleemsituering

Subjectief welbevinden is een veel onderzochte variabele in sociologisch en psychologisch onderzoek bij ouderen. Tal van meetinstrumenten worden gebruikt, korte en omvangrijke, uni- en meerdimensionele, atheoretische en theoretisch onderbouwde. Al deze instrumenten wortelen in de visies inherent aan specifieke onderzoekstradities.¹ De conceptualisering van welbevinden en het construeren van schalen voor de meting ervan zijn blijvende onderzoekstaken, zeker ook in de gerontologie waar welbevinden vaak een afhankelijke variabele is in interventie-onderzoek. Subjectief welbevinden is per definitie een individuele aangelegenheid zowel naar inhoud of extensie als naar intensiteit. Welzijn kan men ervaren met betrekking tot zijn leven als geheel of met betrekking tot verschillende levensdomeinen. Het gewicht van elk levensaspect in het globale subjectieve welbevinden kan van persoon tot persoon verschillen en is ook onderhevig aan maatschappelijke veranderingen. Wat de oudere in het verleden tevreden stelde, zal niet noodzakelijk de oudere van morgen bevredigen. Daarom is het conceptualiseren en operationaliseren van het subjectief welbevinden een continue taak. In dit artikel wordt een zesdimensioneel model van welbevinden bij ouderen beschreven tegen de achtergrond van twee tradities in het onderzoek naar welbevinden en gerapporteerd over de toetsing van het model via een nieuw ontwikkeld zesdimensioneel meetinstrument.

Twee tradities in het onderzoek naar welbevinden

Er wordt momenteel in de literatuur over welbevinden een onderscheid gemaakt tussen twee onderzoekstradities: de hedonistische en de eudaimonische. Ryan en Deci hebben ze recent uitvoerig beschreven.¹ Deze tradities wortelen in onderscheiden visies op de menselijke natuur en op wat goed samenleven betekent. In de hedonische traditie ligt de klemtoon op welbevinden als de maximalisering van (het aantal momenten en de intensiteit van) plezier en genoegen. Een en ander maakt het geluk uit, bestaande uit tevredenheid over het leven, de aanwezigheid van positieve en de afwezigheid van negatieve stemmingen of affecten. Het welbevinden of geluk kan voortkomen uit het bereiken van doelen en waardevol geachte effecten in diverse realiteitsdomeinen. Volgens de eudaimonische visie, teruggaande op Aristoteles, bestaat het welbevinden uit het succesvol

nastreven of realiseren van zijn ware aard. Gekennzeichnet door welbevinden is de persoon die optimaal functioneert en in zijn of haar handelen blijk geeft van 'persoonlijke expressiviteit'.³ Van psychologisch welbevinden zoals Ryff het noemt, is sprake bij de persoon die getuigt van ervaren autonomie, persoonlijke groei, zelfaanvaarding, doelgerichtheid in het leven, greep hebben op de omgeving en positieve sociale relaties.⁴ Een andere theorie binnen deze traditie beklemtoont het slagen in het bevredigen van de drie psychologische behoeften, met name de behoeften aan autonomie, competentie en betrokkenheid op anderen.⁵ Het bereiken van deze doelen en bevredigen van deze behoeften impliceert niet altijd welbevinden in de hedonistische betekenis. De optimale realisatie van de waarachtige menselijke natuur, het ware zelf gaat niet altijd gepaard met prettige gevoelens.

In de eerste visie ligt de klemtoon op de subjectieve evaluatie door de persoon zelf van zijn of haar leven en op de aanwezigheid, frequentie en intensiteit van positieve, respectievelijk, negatieve affecten. In de tweede wordt het welbevinden meer van buitenuit beoordeeld als optimaal functioneren in het perspectief van de zelfrealisatie. Tussen het onderzoek dat op basis van beide visies wordt verricht is overlapping mogelijk.¹

Uit de korte schets blijkt ook dat welbevinden meerdimensioneel is, aangezien het diverse levens- en werkelijkheidsgebieden kan betreffen. Deze meerledigheid vindt men ook terug in de in de literatuur vaak voorkomende specificaties van welbevinden met adjectieven als lichamelijk, psychologisch, sociaal, spiritueel, existentieel, religieus, economisch enz. Daar de diverse domeinen van zelf- en wereldbeleving mede met de leeftijd evolueren is het zinvol welbevinden, en zeker de operationalisering ervan, specifiek voor een bepaalde levensfase te conceptualiseren. In dit artikel wordt gefocust op ouderen.

Een zesdimensioneel model van subjectief welbevinden

Marcoen stelde een zesdimensioneel model van welbevinden bij ouderen voor dat elementen van de twee beschreven tradities verenigt. Er wordt uitgegaan van enkele basisassumpties.⁶⁻⁸ Ten eerste, subjectief welbevinden is het beleefde (niet altijd bewuste), het verwoorde of het besproken resultaat van een vergelijking tussen de eigen waargenomen situatie en de impliciete of expliciete verwachtingen die men daarvan heeft. Ten tweede, de persoon is een relationeel wezen, intentioneel gericht op diverse aspecten of domeinen van de realiteit. Met betrekking tot elk van die domeinen kan de persoon al of niet congruentie ervaren tussen de gewenste en de actuele situatie. Ten derde, het globaal subjectief welbevinden steunt op het welbevinden in de verschillende gebieden, en de verschillende dimensies van welbevinden zijn dyna-

misch op elkaar betrokken. Deze drie assumpties steunen uiteraard op een keuze uit de vele mogelijke conceptuele benaderingen van het complexe fenomeen, dat met termen als welbevinden, geluk, mentale gezondheid en levens-tevredenheid, wordt aangeduid.⁹

Iemand die op de eenvoudige vraag "Hoe maakt u het?" een uitvoerig antwoord geeft, zal spontaan diverse aspecten van zijn persoon en de situatie waarin hij of zij zich bevindt, evalueren. De lichamelijke conditie, de psychische gesteldheid, de sociale relaties, de financiële situatie, en zoveel andere aspecten komen dan aan bod. Aan het subjectieve welbevinden kan men derhalve verschillende dimensies onderscheiden, naargelang de domeinen van de werkelijkheid binnen en buiten de persoon. In dit onderzoek onderscheiden we de volgende domeinen: (1) de eigen innerlijkheid (de psyche, het zelf), (2) het eigen lichaam, (3) de anderen, (4) de cultuur, (5) het materieel milieu, en (6) het existentiële gebied van het ultieme (het Zijn, het Bestaan, het Zijnsmysterie, God). In elk van deze gebieden wordt de persoon geconfronteerd met gegevens en taken, die kunnen veranderen en in de subjectieve beleving bron zijn of bron gemaakt worden van welbevinden en onwelbevinden. Uit eerder onderzoek met diepte-interviews bleek dat ouderen deze domeinen herkennen als gebieden waarop welbevinden kan beoordeeld worden.¹⁰ We bespreken hier kort de zes dimensies.

Het *psychische welbevinden* heeft betrekking op het zich al dan niet, of meer of minder goed voelen in zijn psychologische levensruimte,¹¹ dit is in de wereld van gedachten, herinneringen, verlangens en gevoelens. Het refereert naar: tevreden zijn met het beeld dat men van zichzelf heeft, vrede gevonden hebben met zijn verleden, het heden de moeite waard vinden en niettegenstaande de ervaring van de eindigheid en het vooruitzicht van het sterven, nog toekomstperspectief hebben. Het impliceert ook het gevoel van greep te hebben op zijn omgeving (meesterschap) en te beschikken over copingmechanismen om onvermijdelijke verliessituaties het hoofd te kunnen bieden.

Het *lichamelijke welbevinden* omvat de positieve lichaamsbeleving, het gevoel van zintuiglijke en motorische competentie en de positieve evaluatie van het uiterlijk voorkomen. Het bezit en de handhaving van een positief fysiek zelfconcept is een belangrijke bouwsteen van het welbevinden. Het lichamelijk zelfconcept dat in grote mate en meestal een onbewust gegeven is, wordt door het verouderen van alle orgaansystemen uitgedaagd.¹² Als het lichaam niet meer op een vanzelfsprekende wijze ter beschikking is voor de vervulling van de dagelijkse taken en het in de ogen van anderen en in de spiegel gereflecteerde lichaamsbeeld niet meer aan het gewenste beeld beantwoordt, kan de impliciete positieve beleving veranderen in een meer bewuste negatieve evaluatie.

De positieve beleving van zijn lichamelijk kunnen en voorkomen is ook belangrijk om zich goed te voelen in de sociale omgeving. Als die positief reageert op zijn of haar voorkomen, put ook de oudere mens daaruit een gevoel van welbehagen.

Dit brengt ons bij een derde vorm van welbevinden, het *sociale welbevinden*. Elke mens is gevat in een netwerk van sociale relaties. Er zijn het gezin, de familie, de collega's, de vriendengroep, de vereniging, de buurt, enz. De contacten in deze settings genereren welbevinden als ze tegemoetkomen aan de individuele verwachtingen over de hoeveelheid, de omvang en de diepgang van de relaties. De weldadige kern van het sociale welbevinden ligt in de ervaring van (nog) erbij te horen en van, enerzijds, het gevoel van voor anderen iets te betekenen en, anderzijds, het besef op betekenisvolle anderen te kunnen rekenen. Tegenover dit welbevinden staat de eenzaamheid, de sociale isolatie van het er niet bij horen en het emotionele isolement, als een intieme relatie met een partner of andere vertrouweling ontbreekt.¹³ Een ander aspect van het welbevinden is het *materiële welbevinden* dat betrekking heeft op het materiële milieu en de materiële levenscondities. De relaties met zichzelf, zijn lichaam en de anderen situeren zich in een materiële context die tot de optimalisering van deze relaties bijdraagt. De kwaliteit van de woning, de woninguitrusting en de woonomgeving, de beschikbaarheid van verplaatsingsmiddelen, adequate kleding, gezonde voeding, het inkomen, etc. kunnen bijdragen tot de kwaliteit van het leven. Objectieve verschillen in het materiële comfort reflecteren zich echter niet noodzakelijk in verschillen in subjectief materiële welbevinden.

Het materiële milieu is uiteraard voor het grootste gedeelte mede uiting van de cultuur. Het is een product van de menselijke geest net zoals heel het intellectueel, kunstzinnig en technisch erfgoed dat van generatie op generatie, steeds vernieuwd wordt doorgegeven. Hier situeert zich de bron van het *culturele welbevinden*. De mens vormt en leidt zijn leven in een culturele context die grote invloed heeft op de levensstructuur en de identiteit van de persoon. In de omgang met de producten van de geest die de eigenheid van een bepaalde cultuur uitmaken ontstaan behoeften aan de ontmoeting met bijvoorbeeld artistieke producten en producties, aan rituelen, aan structurering en ordening van de ruimte en de samenhang. Cultureel welbevinden betekent enerzijds, zich goed voelen in de actuele samenleving, zich niet overspoeld voelen door veranderingen, continuïteit ervaren in denken en handelen, anderzijds, het genieten van kunstzinnige, filosofische en maatschappelijke producten.

Een zesde dimensie van welzijn, het *existentiële welbevinden*, heeft betrekking op de existentiële ervaring van als mens in een wellicht nooit geheel te doorgronden kosmos en steeds evoluerende wereld gebo-

ren te zijn en na een min of meer lange levensloop te zullen sterven. Dit is het gebied van de grote vragen naar de zin van het bestaan. Veel mensen hebben behoefte aan een ervaring van gedragen te worden door een realiteit die hen overstijgt en die eenheid geeft en zin aan hun bestaan. Existentieel welbevinden impliceert de ervaring van zin, orde en richting in het bestaan in het algemeen en in het persoonlijk leven.

Interne dynamiek en context van welbevinden

De verschillende dimensies van welbevinden bestaan niet los van elkaar.⁷ Ze vormen een min of meer hiërarchisch geïntegreerd en interdependent systeem van globaal welbevinden. Alle dragen ze in een wisselende wijze bij tot het globale subjectieve welbevinden. De zes werkelijkheidsdomeinen zijn voor elk individu niet even belangrijk zodat een objectief tekort gemeten aan een binnen de groep of cultuur geldende algemene norm, voor de een wel en voor de ander niet aanleiding zal zijn tot een verminderd welbevinden. De verwachtingen over de optimale toestand van de verschillende werkelijkheidsdomeinen kunnen veranderen in de tijd, zodat de structuur van het subjectieve welbevinden ook verandert. Soms kan persoonlijk welbevinden alleen nog worden bereikt door de integratie van de verschillende welzijnsbronnen waarbij het accent verlegd wordt naar het welzijnsgebied dat het minst door objectieve en onomkeerbare bestaanscondities wordt geraakt. Zo is het mogelijk dat iemand door fysieke aftakeling ook effectief weinig lichamelijk welbevinden ervaart maar doordat hij liefdevol omringd wordt door zijn familie, een groot sociaal welbevinden ervaart. Dit in sociale relaties gewortelde welbevinden zal dan compenseren voor het tekort aan lichamelijk welbevinden. Uiteraard is het compensatorisch vermogen van de dimensies niet even groot. Welbevinden in de sfeer van de fundamentele bestaanservaring, de ervaring van ultieme zin, hoe dan ook gefundeerd, lijkt de laatste dam tegen de algehele teloorgang van het subjectieve welbevinden.

Onderzoeksdoel

Het doel van het empirisch onderzoek is tweevoudig, maar de twee doelen hangen nauw samen. Het eerste was de toetsing van het zesdimensioneel model van welbevinden bij ouderen. Kan men de zes beschreven dimensies van welbevinden en hun samenhang bij ouderen terugvinden? Om dit na te gaan werd gebruik gemaakt van een voor dit doel samengesteld meetinstrument. Derhalve is een tweede doel de verdere ontwikkeling van een intern consistent instrument voor de meting van de zes dimensies. Als een eerste aanzet tot validering van de schalen werden ook verbanden nagegaan tussen de zes schalen en een aantal demografische en persoonsvariabelen, waaronder enkele waarvan kan vermoed worden dat ze

eerder met de ene dan met de andere subschaalscore verband zullen houden. Zo kan men verwachten dat het artsbezoek en medicatie verband zullen houden met lichamelijk welbevinden, en dat kinderen en vrienden een bron zijn van sociaal welbevinden. Ten slotte werd ook het belang van de zes domeinen van welbevinden voor de ouderen nagegaan, waardoor op een exploratieve wijze het gemeten welzijn in verband kan gebracht worden met het belang dat eraan gehecht wordt in deze steekproef van ouderen.

Methode

Respondenten

De respondenten voor dit onderzoek werden geworven einde 1999, begin 2000, in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant via verenigingen van senioren, een afdeling voor ouderen in een revalidatiecentrum, een bejaardentehuis en vrienden en kennissen van de auteurs volgens de sneeuwbalprocedure. Dit leidde tot een onderzoeksgroep van 366 ouderen, 143 mannen (39%) en 223 vrouwen (61%), allen ouder dan 60 jaar. Hun leeftijd situeerde zich tussen 60 en 95 jaar ($M = 70,9$; $SD = 6,9$). Iets meer dan de helft (52,7%) was tussen 65 en 75 jaar oud. Drie kwart was gepensioneerd, ongeveer 23 procent was huisvrouw terwijl nog 10 respondenten beroepsactief waren (2,7%). Ongeveer tweederde was gehuwd, bijna eenderde weduwe of weduwnaar; 1,9 procent was gescheiden en 4,4 procent was nooit gehuwd geweest. Drie personen woonden samen (0,8%). Op het ogenblik van het onderzoek woonde 90,6 procent thuis en 4,4 procent in een bejaardentehuis. De rest woonde bij iemand in of woonde in een klooster, een service-flat of elders. Veertien respondenten (3,8%) verbleven in een revalidatiecentrum. De onderzoeksgroep was wat de vermelde verdeling betreft tot op zekere hoogte representatief. Vergeleken met demografische gegevens voor Vlaanderen uit 1998, was er een lichte overrepresentatie van 65 tot 79 jarigen, gehuwden en collectief of samenwonenden.¹⁴ 17 procent woonde in een grote stad (bv. Antwerpen), 19 in een kleine provinciestad, en 64 in een dorp.

Van de onderzoeksgroep had bijna eenderde enkel de lagere school voltooid, een klein aantal daarvan volgde nadien nog avondschoon, nog eenderde volgde lager middelbaar onderwijs, bij de meesten aangevuld met avondschoon. Ongeveer 47 procent gaf een inkomen aan van minder dan 40.000 BEF (€ 991,57) per maand, ongeveer acht procent liet deze vraag onbeantwoord, de overige 45 procent gaf een inkomen aan van meer dan 40.000 BEF. De helft van de respondenten ging één of twee keer per jaar op reis, bijna 40 procent nooit, de overigen minstens drie keer per jaar. Ruim 90 procent was katholiek. Tweederde was lid van een vereniging, en de helft ging minstens maandelijks naar een bijeenkomst. Bijna 13 procent had ooit psychologische hulp gezocht, hoofdzakelijk bij de huisarts.

Instrumenten

Meting dimensies van welbevinden

De samenstelling van de itempool voor de zes schalen van subjectief welbevinden steunde op de resultaten van twee vroegere onderzoeken. In de eerste studie werden items gegenereerd op basis van diepte-interviews met 22 ouderen over de zes domeinen van welbevinden.¹⁵ In de tweede werden bestaande schalen gebruikt voor de meting van vier van de zes dimensies van welbevinden naast twee zelfgemaakte schalen voor de meting van materieel en cultureel welbevinden. Op de vijftien gebruikte schalen, deels bekomen na exploratieve factoranalyse, werd met succes een confirmatorische factoranalyse uitgevoerd waarbij zes latente variabelen werden verondersteld overeenkomstig de zes dimensies van het model.¹⁶

Na een kritische analyse van de in deze beide studies gebruikte items, werd een vernieuwde en aangevulde itempool samengesteld. Items die in deze studies hoog laadden op in het kader van het model relevante factoren, werden geselecteerd en aangevuld met nieuwe items. Aan de formulering van de items werd bijzondere aandacht besteed overeenkomstig de adviezen van De Boeck.¹⁷ Zo werd er gestreefd naar items die slechts één gedachte weergaven en geen negaties of frequenties bevatten. Frequenties en intensiteiten kwamen enkel voor in de antwoordmogelijkheden. Ook werd zoveel mogelijk de eerste persoon enkelvoud gebruikt.

De nieuw samengestelde schaal voor de meting van subjectief welbevinden bestond uit 72 items, 12 items voor de subschalen lichamelijk, materieel en sociaal welbevinden, 11 voor cultureel en existentieel en 14 voor psychisch welbevinden. De items werden beantwoord op een zevenpuntenschaal, voor 41 items gaande van "nooit" (1) over "zelden", "eerder zelden", "soms", "vaak", "zeer vaak" tot "altijd" (7) en voor 31 items tussen "helemaal niet akkoord" (1) en "helemaal akkoord" (7) met als neutraal punt "ik weet het niet" (4).

Ook werd met een zevenpuntenschaal, gaande van "helemaal niet belangrijk" (1) tot "heel belangrijk" (7), gemeten hoe belangrijk de respondenten elk van de zes domeinen vonden. Voor de termen waarmee de domeinen werden aangegeven zie tabel 3.

Personalievragenlijst

In de personalievragenlijst wordt een aantal demografische en persoonsgebonden variabelen bevraagd. Naast vragen naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, aantal kinderen en kleinkinderen, genoten onderwijs en beroepscategorie worden ook vragen gesteld over de frequentie van het artsbezoek, medicatie, subjectieve gezondheidsevaluatie, woonsituatie (zelfstandig/collectief), inkomen, reizen, lidmaatschap van verenigingen, (on)gelovig zijn en recent gezochte psychische ondersteuning.

Procedure

Niet alle schalen waren door iedereen volledig ingevuld. Scores ontbraken voor 1,8% van het totale aantal in te vullen items. Dit probleem werd opgelost door de multiple imputation procedure zoals voorgesteld door Schafer,¹⁸ waardoor in verdere analyses steeds de gegevens van alle deelnemers konden worden gebruikt. Op alle schalen werd een itemanalyse en exploratieve factoranalyse uitgevoerd ten einde de items te selecteren waarmee interne consistente schalen konden gevormd worden. De verbanden tussen de schalen en demografische en persoonsvariabelen werden nagegaan met variantieanalyse.

Resultaten

Itemanalyse en psychometrische kenmerken

In tabel 1 wordt per schaal de Cronbachs alfa van de apriorischaal aangegeven, de nummers van de verwijderde items en de alfacoëfficiënt van de gereduceerde schaal. De schalen met alle items zijn weergegeven in een bijlage.

De schaal Psychisch Welbevinden bleek behoorlijk homogeen te zijn. Geen items dienden verwijderd te worden. De betrouwbaarheid van Lichamelijk Welbevinden kon verbeterd worden door twee items te verwijderen. Beide negatief geformuleerde items verwezen naar een storend zintuiglijk functioneren. De alfacoëfficiënt van Sociaal Welbevinden kon gevoelig verbeterd worden door drie items met een lage item-testcorrelatie te verwijderen. Deze drie refererden naar sociale vaardigheden die men al of niet bij zichzelf aanwezig ziet. Uit Materieel Welbevinden werden twee items verwijderd over het verlangen naar luxe en over de kosten van levensonderhoud. De alfacoëfficiënt van Cultureel Welbevinden is zeer laag. Een exploratieve factoranalyse met twee of drie factoren reveleerde de aparte positie van vier negatief geformuleerde items (15, 27, 33, 62) en na itemanalyse op de resterende zeven items bleek de verwijdering van nog een item (9) de alfacoëfficiënt op een relatief aanvaardbaar niveau te brengen. Existentieel Welbevinden vertoonde een redelijk niveau van betrouwbaarheid. De op het zicht inhoudelijke tweeledigheid van de schaal, het leven als zinvol ervaren, respectievelijk, angst voor sterven en dood, werd

door een exploratieve factoranalyse bevestigd. Een en ander leidde tot verwijdering van onder andere de drie negatief geformuleerde eindigheidsitems en één nog resterend negatief item (30). De alfacoëfficiënt van de schaal met de resterende items werd hierdoor gevoelig hoger.

Itemanalyse en eventuele factoranalyse op de afzonderlijke schalen leidde tot de selectie van 56 van de oorspronkelijke 72 items. De Cronbach alfacoëfficiënten van de op één na gereduceerde schalen situeren zich tussen alfa 0,89 en 0,61.

Alle correlaties tussen de schalen waren significant (zie tabel 2). Ze situeerden zich tussen 0,23 en 0,70 (Me=0,54). De scores van welbevinden lagen op een behoorlijk hoog niveau. Voor Materieel en Sociaal welbevinden waren de scores het hoogst (6,02 en 6,96) en voor Lichamelijk welbevinden het laagst (4,97). De standaarddeviatie was voor deze laatste schaal ook het grootst.

Waargenomen belang van de dimensies

Zoals verwacht scoorde het domein lichamelijk welbevinden hoog: 90,4% van de respondenten vond dit belangrijk of heel belangrijk. Ook het existentiële en het psychische domein scoorden hoog met percentages van 89,6 en 83,7. Iets minder hoog scoorden de sociale relaties (80,1%). Het percentage voor het materiële domein was nog lager (72,7%) en voor het culturele was het slechts 39,7%. Deze hiërarchie werd ook gereflecteerd in de schaalgemiddelden (zie tabel 3). Daarbij viel voor de twee laagst scorende domeinen ook de grotere standaarddeviatie op.

Tabel 2. Interrelaties*, gemiddelde en standaarddeviatie van de schalen. (correlations, means and standard deviations of the scales)

Schalen	LW	SW	MW	CW	EW	M	SD
Psychisch (PW)	0,59	0,65	0,39	0,70	0,64	5,45	0,76
Lichamelijk (LW)		0,39	0,23	0,42	0,33	4,97	1,02
Sociaal (SW)			0,53	0,60	0,54	5,96	0,76
Materieel (MW)				0,54	0,40	6,02	0,75
Cultureel (CW)					0,61	5,39	0,76
Existentieel (EW)						5,30	0,90

*Alle correlaties zijn significant op het 0,01 niveau.

Tabel 3. Belangschalen: Gemiddelden en standaarddeviaties van de belangitems (Importance scales: Means and standard deviations)

Apriori schaal	Item	M	SD
Lich.	Mij lichamelijk goed voelen is voor mij...	6,34	0,84
Exist.	Dat het leven zin heeft is voor mij...	6,31	0,89
Psych.	Tevreden zijn met mijzelf is voor mij...	6,20	0,89
Soc.	Tevreden zijn met mijn sociale contacten is voor mij...	5,95	1,01
Mater.	Materieel niets tekort komen is voor mij...	5,81	1,14
Cult.	Op cultureel gebied niets tekort komen is voor mij.	4,92	1,43

*Lich. = lichamelijk, Exist. = existentieel, Psych. = psychologisch, Soc. = sociaal, Mater. = materieel, Cult. = cultureel

Geslachts- en leeftijdsverschillen

Een 2 (geslacht) X 5 (leeftijd) variantie-analyse leverde weinig resultaten op. Een significant geslachtsverschil werd alleen vastgesteld voor Lichamelijk Welbevinden. Mannen scoorden hoger dan vrouwen, 5,24 versus 4,82, $F(1,352) = 11,26$, $p < 0,001$. Enkele verschillen met betrekking tot andere observaties bevestigden dit. Vrouwen raadpleegden vaker dan mannen een arts, $\chi^2(1, N = 360) = 9,74$, $p < 0,01$, en ze namen ook meer soorten medicijnen per dag, $\chi^2(1, N = 360) = 9,34$, $p < 0,05$. Voor zover het voorkwam waren het ook vrouwen die vaker dan mannen in het voorbije jaar psychologische steun zochten, $\chi^2(1, N = 360) = 6,65$, $p < 0,01$.

Andere demografische en persoonsvariabelen

Een aantal demografische en persoonsvariabelen hing samen met verschillen in welbevinden voor de verschillende schalen (zie tabel 4). Dit werd nagegaan met variantie-analyse waarbij paarsgewijze meervoudige vergelijkingen werden gecorrigeerd volgens Bonferroni.¹⁹ Het grootste aantal verbanden werd vastgesteld voor Lichamelijk Welbevinden, en verder voor Existentieel, Cultureel en Psychisch Welbevinden.

Op Psychisch Welbevinden scoorden hoger: ouderen met één of meer dochters (in vergelijking met ouderen zonder dochters), ouderen die nog zelfstandig wonen, vier of meer vrienden hebben (tegenover minder dan vier), lid zijn van een vereniging(en) en in het voorbije jaar geen psychische steun zochten.

Tabel 4. Significante verschillen voor de dimensies van welbevinden in functie van een aantal demografische en persoonsvariabelen (Significant differences between scores on well-being scales in relation to demographic and person-related variables)

Demografische en persoonsvariabelen	Psychisch	Lichamelijk	Sociaal	Materieel	Cultureel	Existentieel
Burgerlijke staat		$F(1,364) = 4,23^*$				
Met partner/zonder partner		5,06 vs 5,82*				
Aantal kinderen					$F(2,362) = 4,00^*$	$F(2,362) = 3,33^*$
Vier of meer/minder					5,72 vs 5,46*	5,49 vs 5,22*
Aantal dochters	$F(1,352) = 12,64^{***}$	$F(1,352) = 4,82^{**}$	$F(1,352) = 10,61^{***}$		$F(1,352) = 7,04^{**}$	$F(1,352) = 4,28^*$
Eén of meer/geen	5,53 vs 5,21***	5,05 vs 4,78	6,03 vs 5,74***		5,59 vs 5,35**	5,35 vs 5,13*
Aantal thuiswonende kinderen				$F(1,310) = 5,92^*$	$F(1,310) = 3,98^*$	$F(1,310) = 4,14^*$
Eén of meer/geen				6,28 vs 6,02*	5,75 vs 5,52*	5,54 vs 5,26*
Aantal kleinkinderen					$F(4,355) = 2,76^*$	$F(4,355) = 4,62^{***}$
Negen of meer/één of twee					5,82 vs 5,45*	5,70 vs 5,10***
Negen of meer/drie tot vijf					5,82 vs 5,45*	5,70 vs 5,24*
Woonsituatie	$F(1,358) = 5,24^*$			$F(1,358) = 4,06^*$		
Zelfstandig/collectief	5,73 vs 5,42*			6,27 vs 6,00*		
Woonplaats		$F(2,361) = 6,42^{**}$				
Grote stad/kleine stad		5,32 vs 4,68***				
Grote stad/dorp		5,32 vs 4,96*				
Aantal reizen per jaar		$F(2,333) = 3,53^*$				$F(2,333) = 3,05^*$
Meermaals/nooit		5,19 vs 4,84*				
Nooit/één keer						5,40 vs 5,11*
Aantal goede vrienden	$F(1,353) = 15,77^{***}$	$F(1,353) = 9,79^{**}$	$F(1,353) = 21,78^{***}$		$F(1,353) = 4,36^*$	$F(1,353) = 4,56^*$
Vier of meer/minder dan vier	5,55 vs 5,20*	5,08 vs 4,70*	6,07 vs 5,66*		5,59 vs 5,41*	5,36 vs 5,13*
Aantal artsbezoeken per maand		$F(1,358) = 66,31^{***}$				
Minder dan één/één of meer		5,31 vs 4,49***				
Aantal geneesmiddelen per dag		$F(2,343) = 20,65^{***}$				
Geen/één of twee		5,84 vs 5,12*				
Geen/drie of meer		5,84 vs 4,63***				
Eén of twee/drie of meer		5,12 vs 4,63***				
Lid van verenigingen	$F(1,362) = 5,32^*$	$F(1,362) = 9,13^{**}$				
Lid/geen lid	5,51 vs 5,31*	5,08 vs 4,74**				
Aantal vergaderingen per maand		$F(5,237) = 3,53^{**}$			$F(5,237) = 2,77^*$	
Meer dan één keer/nooit		5,49 vs 4,52**				
Meer dan één keer per maand/één keer per week					5,81 vs 5,31	
Psychische steun gezocht in voorbije jaar	$F(1,358) = 12,07^{***}$	$F(1,358) = 29,24^{***}$				
Geen/wel	5,50 vs 5,10***	5,08 vs 4,27***				
Gelovig						$F(1,355) = 9,73^{**}$
Wel/niet						5,33 vs 4,75**

* $p < .05$

** $p < .01$

*** $p < .001$

Met Lichamelijk Welbevinden, hielden heel wat variabelen verband. Ouderen die vergelijkenderwijs hoger scoorden, leven vaker met een partner, hebben één of meer dochters, wonen in een grote stad (versus kleine stad of dorp), gaan meermaals per jaar op reis (tegenover diegene die nooit op reis gaan), hebben vier of meer goede vrienden, bezoeken een arts minder dan eens per maand, nemen geen (versus een of twee, drie of meer) of slechts één of twee (versus drie of meer) geneesmiddelen per dag, zijn lid van verenigingen, nemen meer dan eens per maand maar minder dan eens per week (versus nooit) deel aan een vergadering en hebben in het voorbije jaar geen psychische steun gezocht.

Hogere scores op Sociaal Welbevinden werden gevonden bij ouderen met één of meer dochters en vier of meer goede vrienden. Ouderen die nog één of meer thuiswonende kinderen hebben of nog zelfstandig wonen hadden vergelijkenderwijs hogere scores op Materieel Welbevinden.

Op de schalen Cultureel en Existentieel Welbevinden scoorden die ouderen hoger die vier of meer kinderen hebben (tegenover één tot drie kinderen), één of meer dochters, één of meer thuiswonende kinderen, negen of meer kleinkinderen en vier of meer goede vrienden hebben. Daarenboven scoorden hoger op Cultureel Welbevinden de ouderen die een paar keren per maand (versus wekelijks) een vergadering bijwonen, en hoger op Existentieel Welbevinden de ouderen die nooit op reis gaan tegenover die één keer per jaar op reis gaan, en diegenen die zich gelovig noemen.

Belangrijk is ook dat de scores op de meting van de subjectieve gezondheid significant ($p < 0,01$) correleerden met alle schalen, maar het hoogst met Lichamelijk Welbevinden ($r = 0,66$). De andere correlaties lagen tussen 0,15 en 0,32.

Het overzicht in tabel 4 leert dat bij de ouderen die een dochter of dochters hebben en minstens vier vrienden hebben, hogere scores worden aangetroffen voor alle schalen behalve voor Materieel Welbevinden. Met drie variabelen werden geen significante verbanden vastgesteld, met name, met het al of niet hebben van zonen, het niveau van het genoten onderwys en het inkomen.

Bespreking

Geïnspireerd door het zesdimensionele model van subjectief welbevinden werden zes schalen samengesteld die aan 366 60-plussers werden voorgelegd. De analyse van de gegevens ondersteunt het model. Itemanalyse en exploratieve factoranalyse van de afzonderlijke schalen leverden zes significante en soms zeer hoog correlerende schalen op met een behoorlijke interne consistentie. De apriori schaal voor Psychisch Welbevinden kon integraal behouden blijven. Voor de meting van Lichamelijk Welbevinden vielen twee negatief geformuleerde specifiek op gezichts- en gehoorsachteruitgang gerichte items uit.

Bij Sociaal Welbevinden bleven de items gericht op sociale aanvaarding en iets betekenen voor anderen over. Items die refereerden naar het hebben van bepaalde sociale vaardigheden vielen uit. De interne consistentie van Materieel Welbevinden kon door het weglaten van twee items nog verbeterd worden zonder dat betekenis van het geheel werd gewijzigd. De resterende items van Cultureel Welbevinden refereren naar zich goed, veilig, comfortabel voelen in de wereld, de samenleving, de buurt en de persoonlijke leefwereld. Existentieel Welbevinden werd na itemanalyse en exploratieve factoranalyse meer homogeen gemaakt door de items over angst voor eindigheid, dood en sterven te verwijderen. De resterende items focussen op de ervaring van zin in het leven.

Alle correlaties tussen de schaalcores waren significant. Psychisch en Cultureel Welbevinden correleerden het hoogst en deze schalen hadden ook de hoogste gemiddelde correlatie met de andere schalen. Het niveau van de correlaties is niet van die aard dat een verder streven naar de ontwikkeling van afzonderlijke schalen onverantwoord zou zijn. Uiteraard moet bij de verder ontwikkeling van schalen blijvende aandacht gaan naar de conceptualisering en operationalisering van de zes dimensies. Nu zijn in sommige schalen items weggevallen die geacht werden een goede weergave te zijn van een aspect van de dimensie. Zodoende dekt de inhoud van de items niet (altijd meer) helemaal het begrip zoals beschreven in de inleiding. Zo is "niet bang zijn van de eindigheid van het bestaan, het sterven en de dood" in Existentieel Welbevinden niet meer vertegenwoordigd. Blijkbaar is dit een fenomeen op zich dat als dusdanig moet benaderd worden. De schalen zoals ze er na dit onderzoek uitzien meten duidelijk onderscheidbare aspecten van Subjectief Welbevinden bij ouderen. Daarenboven vertonen ze een gedifferentieerd patroon van relaties met een aantal demografische en persoonskenmerken.

We stelden één significant geslachts- en één significant leeftijdsverschil vast. Vrouwen scoorden alleen lager op Lichamelijk Welbevinden. Dit resultaat is geen bevestiging van de vaststelling in een recente meta-analytische studie dat oudere vrouwen significant minder subjectief welbevinden en een minder positief zelfbeeld rapporteren dan mannen.²⁰ Over het algemeen blijkt uit onderzoek dat het welbevinden van vrouwen minder groot is als men als criterium neemt de mate waarin ze negatief affect rapporteren. Vrouwen rapporteren in vergelijking met mannen echter niet in mindere mate prettig en positief affect. Met dit gegeven uit de literatuur zijn de resultaten van onze studie wél in overeenstemming in zoverre dat alleen inzake lichamelijk welbevinden een geslachtsverschil werd vastgesteld.²¹⁻²³ De 80-plussers rapporteerden in vergelijking met de jonge senioren (60-64 jaar) meer sociaal welbevinden.

Globaal genomen hadden de ouderen die aan dit

onderzoek deelnamen een behoorlijk niveau van welbevinden op de zes domeinen. De uitspraken werden in doorsnee bevestigd met "akkoord" of "zeer vaak". Deze zich doorgaans goed voelende ouderen ervaarden vooral op materieel en sociaal gebied geen tekorten en hadden alleen op lichamelijk vlak minder extreme gevoelens van welbevinden. Dit laatste contrasteert enigszins met het groot(ste) belang dat door deze ouderen gehecht werd aan het zich lichamelijk goed voelen. Precies op lichamelijk vlak worden ouderen kwetsbaarder. Het is dan ook niet onverwacht dat van de scores op de belangitems die voor Lichamelijk Welbevinden het hoogst was. Gezondheid blijkt inderdaad een centraal levensthema bij ouderen.²⁴ Zo gezond mogelijk en met een positief zelfgevoel een zinvol leven leiden, kwam als de kern van het impliciete welzijnsprogramma van deze groep ouderen naar voren. Goede sociale contacten hebben en materieel niets tekort hebben, waren niet veel minder belangrijk. Het laagst scorende domein was het culturele. Opmerkelijk is dat voor de twee domeinen die als de belangrijkste werden beschouwd (het lichamelijke en het existentiële) het laagst - minst positief - gescoord werd. Impliciet lijkt dit een aanduiding te zijn van de kwetsbare gebieden in het zelfconcept en de levensstructuren van de ouderen en daarom ook van aanknopingspunten voor een educatief aanbod en sociale ondersteuning.

De zinvolheid van het onderscheid tussen de dimensies van welbevinden bleek in dit onderzoek ook uit verbanden tussen de scores op de schalen en enkele demografische en persoonsvariabelen. Dochters en veel goede vrienden hebben lijken protectieve factoren te zijn tegen onwelbevinden op vijf van de zes domeinen (het materiële uitgezonderd). Het is denkbaar dat dochters als primaire hulpverleners en vrienden als centrale extrafamiliale vertrouwelingen op meervoudige wijze bijdragen tot het algemeen welbevinden van ouderen. De belangrijke positie van dochters in de intergenerationele relaties is universeel en het toenemend belang bij ouderen van vrienden die in eerste instantie het welbevinden in stand houden en bevorderen, werd eveneens beklemtoond in de literatuur.²⁵

Een familieverband met dochters, meerdere kinderen en kleinkinderen, en relaties met meerdere, goede vrienden, verhogen bij ouderen de kans op een zich thuis voelen in diverse micro- en macrosettings (zie de items van Cultureel Welbevinden) en het ervaren van het leven als zinvol (Existentieel Welbevinden).

Met betrekking tot de eerste doelstelling levert het onderzoek de bevestiging op van de mogelijkheid bij ouderen zes dimensies van welbevinden te onderscheiden die wel met elkaar verband houden maar genoeg te onderscheiden zijn om een afzonderlijke benadering te rechtvaardigen. In de verdere ontwikkeling van het instrument dat voor deze afzonderlijke

benadering werd samengesteld werden belangrijke stappen gezet. Ten eerste, zes vrij homogene schalen kwamen tot stand. Deze schalen maken het mogelijk het subjectief welbevinden meer gedifferentieerd te meten vanuit een perspectief dat nauw aansluit bij de wijze waarop mensen zich vaak spontaan over hun welbevinden genuanceerd en domeingerelateerd uiten. Ten tweede, de zes schalen vertoonden interessante verbanden met een aantal variabelen, wat een aansporing inhoudt tot verdere exploratie van mogelijke determinanten van de verschillende welzijnsdimensies. Ten derde, de drie meest belangrijk geachte dimensies - lichamelijk, psychisch en existentieel - zijn ook het vaakst gerelateerd aan in dit onderzoek betrokken demografische en persoonsvariabelen. Deze resultaten leiden tot de conclusie dat voortgezet onderzoek naar de zes dimensies van subjectief welbevinden en de meting ervan bij ouderen wenselijk is. Het meetinstrument zou voorts verder moeten worden gevalideerd, onder andere door de afname van de schalen samen met andere instrumenten zowel in meer representatieve als in specifieke groepen van ouderen.²⁶⁻²⁸ Ook de studie van de differentiële impact van persoonskarakteristieken en levensomstandigheden op de diverse aspecten van welbevinden kan tot resultaten leiden ter ondersteuning van het multidimensionele model, en tot het gedifferentieerd beoordelen en bevorderen van welbevinden van ouderen in de psychogerontologische praktijk.⁶

Ten slotte, in dit onderzoek werd uitdrukkelijk niet uitgegaan van één van de twee vermelde onderzoekstradities, de hedonistische en de eudaimonische, maar wel van de assumptie dat als iemand uitspraken doet of beaamt over zijn welbevinden dat dit het resultaat is van een evaluatieproces waarbij de actuele situaties waarin men zich bevindt wordt vergeleken met de gewenste situatie. Dit komt tot uiting in de formulering van de items waarin de zinsneden "tevreden zijn met", "zich goed voelen", "vinden dat (het goed is, gelukt is, enz.)" vaak voorkomen. Items verwijzen zowel naar levenstevredenheid, het bereikt hebben van doelen en de aanwezigheid van positieve en negatieve gevoelens, als naar zelfaanvaarding, een doel hebben in zijn leven en er ook greep op hebben. De ene reeks items hoort eerder thuis in de hedonistische benadering van welbevinden, de andere meer in de eudaimonische traditie. De zesdimensionele schaal situeert zich niet uitgesproken binnen één traditie.

Literatuur

1. Ryan RM, Deci EL. On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. *An Rev Psychol* 2001; 52: 141-66.
2. Diener E, Sapryta JJ, Suh E. Subjective well-being is essential to well-being. *Psychol Inq* 1998; 9: 33-7.
3. Waterman AS. Two conceptions of happiness: Contrasts of personal expressiveness (eudaimonia) and hedonic enjoyment. *J Pers Soc Psychol* 1993; 64: 678-91.
4. Ryff CD. Happiness is everything, or is it? Explorations on

- the meaning of psychological well-being. J Pers Soc Psychol 1989; 57: 1069-81.
5. Ryan RM, Deci EL. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. Am Psychol 2000; 55: 68-78.
6. Marcoen A. Welbevinden bij bejaarden. In: Baeyens JP, red,

- Gerontologie & Geriatrie 1986. Leuven: Acco, 1987; 165-81.
7. Marcoen A. Spirituality and personal well-being in old age. Aging and Society 1994;24:21-36.
8. Marcoen A. Duurzame zelfzorg: Een ethische opdracht. In: Ouderen in solidariteit: Vlaams welzijnscongres 1993. Zaventem: Kluwer, 1993, 161-71

Bijlage Schalen voor welbevinden: Blijvende en verwijderde items

Psychisch welbevinden (14 items)

5. Als ik ontevreden ben over mijn levenssituatie, dan neem ik maatregelen om daar iets aan te veranderen.
11. Ik ben gelukkig om de persoon die ik ben.
17. Ik kan de situatie waarin ik leef aan.
- 23.*Ik voel me verdrietig.
- 29. Ik voel me angstig.
35. Ik hou van het leven.
- 38. Ik voel me afgesloten van de wereld rondom mij.
40. Ik beleef gelukkige momenten.
41. Ik heb mijn eigen leven in handen.
46. Ik vind dat ik me op tijd boven tegenslagen kan zetten.
52. Ik vind dat ik, gezien de omstandigheden, de juiste keuzes maakte in het verleden.
58. Wanneer ik op mijn leven terugblik, ben ik tevreden over hoe de dingen verlopen zijn.
64. Ik hou van de meeste aspecten van mijn persoonlijkheid.
- 69. Ik lig in de knoop met mezelf.

Lichamelijk welbevinden (12 items – 10 items)

1. Ik vind dat ik er goed uitzie.
7. Ik voel me gezond.
- 13. Ik heb pijn.
20. Ik voel me lichamelijk sterk genoeg.
- 25. Ik heb lichamelijke klachten.
- 31. Ik voel me een vreemde in mijn eigen lichaam.
- 37. Mijn lichaam laat me in de steek.
42. Ik ben tevreden over mijn conditie.
48. Ik hou van mijn lichaam zoals het is.
54. Ik voel me lichamelijk goed.
- ***
- 60. Ik heb last van een slecht gehoor.
- 66. Ik heb last van een slecht zicht.

Sociaal welbevinden (12 items – 9 items)

4. Ik voel me aanvaard door de mensen in mijn omgeving.
10. Er zijn mensen die om mij geven.
16. Er zijn mensen op wie ik kan rekenen.
28. Ik ben tevreden met de sociale contacten die ik heb.
34. Mijn kinderen geven om mij.
45. Ik heb in mijn leven tot nu toe voor anderen iets betekend.
51. Ik ben tevreden over het bezoek dat ik krijg.
68. Ik heb de relaties die ik nodig heb.
71. Andere mensen mogen mij.
- ***
- 19. Ik voel me mensenschuw.
- 57. Nauwe relaties onderhouden is moeilijk voor mij.
63. Ik ben in staat om mijn zorgen te delen met iemand anders.

Materieel welbevinden (12 items – 10 items)

2. Ik ben tevreden over het spaargeld dat ik heb.
14. Als ik iets nodig heb, kan ik dat betalen.
26. Materieel gezien heb ik alles wat ik nodig heb.
32. Als ik graag een extraatje heb, dan kan ik dat betalen.
43. Ik ben tevreden met mijn interieur.
49. De elektriciteit in mijn woning is in orde.
55. De verwarming in mijn woning is in orde.
61. Ik vind mijn woning comfortabel.
67. Ik ben tevreden met de welvaart die ik heb.
72. Ik heb alle huishoudtoestellen die ik nodig heb.
- ***
- 8. Ik zou meer luxe-artikelen willen.
- 21. Het leven is voor mij te duur.

Cultureel welbevinden (11 items – 6 items)

3. Ik ben voldoende op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt.
22. Ik voel me goed in de wereld van vandaag.
39. Ik voel me veilig in mijn buurt.
44. Ik ben erin gelukt voor mijzelf een levensstijl te ontwikkelen waarin ik het naar mijn zin heb.
50. Ik voel me thuis waar ik woon.
56. In een multiculturele samenleving voel ik mij op mijn gemak.
- ***
9. Mijn behoefte aan culturele uitstapjes is voldaan.
- 15. De levenswijze van jonge mensen stoort mij.
- 27. Ik kom op cultureel gebied iets tekort.
- 33. Ik heb het moeilijk met bepaalde vernieuwingen in de maatschappij.
- 62. Er is geen respect voor de oudere mensen in onze maatschappij.

Existentieel welbevinden (11 items – 7 items)

6. Ik vind dat elke dag nieuw en anders is.
12. Ik put steun uit een geloof of levensvisie.
47. Ik heb een gevoel van richting of doel in mijn leven.
53. Ik vind dat ik succesvol ben geweest in het bereiken van mijn levensdoelen.
59. Ik vind dat het bestaan een reden heeft.
65. Ik vind dat alles in het leven zin heeft.
70. Ik vind dat de zin van het leven blijkt in de wereld rondom ons.
- ***
- 18. Ik heb schrik om te sterven.
24. Ik kan de dood aanvaarden.
- 30. Ik mis een goede levensvisie.
- 36. Ik heb angst als ik over de dood nadenk.

* De scores van items voorafgegaan door een -teken worden omgekeerd. De verwijderde items zijn in een afgezonderde reeks aangegeven voor elke schaal. + Deze vragenlijst is vrij beschikbaar voor geïnteresseerde onderzoekers.

9. Veenhoven R. Questions on happiness: Classical topics, modern answers, blind spots. In: Strack F, Argyle M, Schwarz N, eds, Subjective well-being: An interdisciplinary perspective. Oxford: Pergamon, 1997; 7-26.
10. Amelinckx E, Dimensies van welbevinden op oudere leeftijd: Exploratieve analyse, constructie van een meetinstrument en empirisch onderzoek. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, K.U.Leuven, 1997.
11. Thomae H. Das Individuum und seine Welt, Göttingen: Hogrefe, 1968. Old age in our time. New York: Norton, 1986.
12. Whitbourne SK. The aging body. New York: Springer-Verlag, 1985.
13. Weiss RS. Loneliness: The experience of emotional and social isolation. Cambridge, MA: MIT Press, 1973.
14. Audenaert V, Jacobs T, Poulain M. Transitie van de huishoudelijke situaties van ouderen. Brussel: CBGS, 2000.
15. Amelinckx E, Marcoen A. Dimensies van welbevinden op oudere leeftijd: Kwalitatieve exploratie, schaalconstructie en belang-realistieanalyse. Paper Winter Meeting Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie 1998.
16. Marcoen A, Linsen I, Van Ranst N. Een zesdimensioneel model van subjectief welbevinden: Een empirische toetsing bij ouderen. Paper Winter Meeting Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie 1998.
17. De Boeck P. Principes en methoden van de psychodiagnostiek. Cursustekst 1998.
18. Schafer JL. Analysis of incomplete multivariate data (Monographs on Statistics and Applied Probability, No. 72). London: Chapman & Hall, 1997.
19. Kirk RE. Experimental design: Procedures for the behavioral Sciences (2nd ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/ Cole, 1982.

20. Pinquart M, Sörensen S. Gender differences in self-concept and psychological well-being in old age: A meta-analysis. J Gerontol: Psychol Sci 2001; 56B: P195 - P213
21. Smith J, Baltes M-M. The role of gender in very old age: Profiles of functioning and everyday life patterns. Psychol Aging, 1998; 13: 676-95.
22. Lucas RE, Gohm CL. Age and sex differences in subjective well-being across cultures. In: Diener E, Suh EM, eds, Culture and subjective well-being. Cambridge MA: MIT Press, 2000; 291-317.
23. Nolen-Hoeksema S. Gender differences in well-being. In: Kahneman D, Diener E, Schwarz N, eds, Well-being: The foundations of hedonic psychology. New York: Russell Sage Foundation, 1999; 330-50.
24. Westerhof G.J., Kuin Y, Dittmann-Kohli F. Gesundheit als Lebensthema. Z klin Psychol, 1998; 27: 136-42.
25. Carstensen L, Social and emotional patterns in adulthood: Support for socioemotional selectivity theory. Psychol Aging, 1992; 7: 331-8.
26. Kempen GJM, Ormel J. Het meten van psychologisch welbevinden bij ouderen. Tijdschr Gerontol Geriatr 1992; 23: 225-35.
27. Linschoten CP van, Gerritsen JC, Romijn C. De Schaal Subjectief Welzijn Ouderen nader onderzocht. Tijdschr Gerontol Geriatr 1993; 24: 57-65.
28. Eijk LM van, Kempen GJM, Sonderen FLP van. Een korte schaal voor het meten van sociale steun bij ouderen: de SSL12-I. Tijdschr Gerontol Geriatr 1994; 25: 192-6.

Aanvaard: augustus 2002

Boekbespreking

Harry van der Wiel en Jan Wouda. *Zelfzorg in de palliatieve fase*. Houten/Diegem: Bohn, Stafleu Van Loghum, 2001. 48 p., € 13,84

Werk maken van je eigen werk, zelfmanagement, dat is de kern van dit Pallium-cahier. De kunst is om ondanks de werkdruk ervoor te zorgen dat je met optimaal plezier en effect palliatieve zorg kunt verlenen en daarmee burn-out kunt voorkomen, want werken in de palliatieve zorg is emotioneel zwaar, volgens de auteurs. Om ondanks tegenslagen in je werk gemotiveerd aan de slag te blijven, worden er bijzondere kwaliteiten van de hulpverlener gevraagd. Om het zoeken naar, en het bewaren van een juiste balans tussen draaglast en draagkracht te bevorderen, is dit cahier geschreven. Het biedt inzicht in de factoren die bepalend zijn voor het plezier en de belasting in het werk. Ook geeft het boekje een aantal praktische richtlijnen en adviezen over bijv. hoe je jezelf minder kwetsbaar kunt maken in emotioneel sterk belastende situaties. Aan het einde van ieder hoofdstuk staat een vragenlijst en een oefening. Deze kunnen worden beschouwd als in-

strument om te groeien in de rol van professional in de palliatieve zorg. Ze maken evenals de casuïstiek het cahier levendig; het is heel toegankelijk geschreven. Het is echter te betreuren dat de auteurs regelmatig dingen beweren ('veelal heb je als hulpverlener daarbij [bij het uitvoerig ingaan op de emoties van een patiënt en zijn naasten] niet in de gaten dat je eigen emotionele leven er relatief bekaaid vanaf komt' of 'probleem oplossen is in feite waar het in de professionele hulpverlening om gaat') zonder ze verder toe te lichten of te onderbouwen.

Maaïke Hermesen, Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde, UMC St Radboud, Nijmegen